神仙解语丹联合电项针刺激疗法对中风后言语障碍患者语言功能和预后的影响*

杨晓鸿①

【摘要】 **目的：**探究神仙解语丹联合电项针刺激疗法对中风后言语障碍患者语言功能和预后的影响。**方法：**选择赣州市人民医院 2021 年 10 月—2022 年 8 月收治的 200 例中风后言语障碍患者作为研究对象，采用随机数字表法，分为参考组（n=100）和观察组（n=100）。参考组进行常规西药治疗和电项针刺激疗法，观察组在参考组基础上采用神仙解语丹治疗。比较两组总有效率、语言功能、认知能力、日常生活能力及不良反应发生率。**结果：**观察组总有效率高于参考组，差异有统计学意义（P<0.05）。两组治疗前语言功能比较，差异无统计学意义（P>0.05）；治疗后观察组语言功能评分高于参考组，差异有统计学意义（P<0.05）。两组治疗前日常生活能力量表（ADL）及蒙特利尔认知评估量表（MoCA）评分比较，差异均无统计学意义（P>0.05）；治疗后观察组 MoCA、ADL 评分均高于参考组，差异均有统计学意义（P<0.05）。两组不良反应发生率比较，差异无统计学意义（P>0.05）。**结论：**神仙解语丹联合电项针刺激疗法治疗中风后言语障碍的效果优良，能有效提高其语言功能，改善患者认知能力，预后效果良好。

【关键词】 神仙解语丹　电项针刺激疗法　中风　言语障碍　语言功能

Effect of Shenxian Jieyu Pills Combined with Electro-nape-acupuncture Stimulation Therapy on Language Function and Prognosis of Patients with Dysphasia after Stroke/YANG Xiaohong. //Medical Innovation of China, 2023, 20(29): 123-126

[Abstract]　Objective: To investigate the effect of Shenxian Jieyu Pills combined with electro-nape-acupuncture stimulation therapy on language function and prognosis of patients with dysphasia after stroke. **Method:** A total of 200 patients with dysphasia after stroke admitted to Ganzhou People's Hospital from October 2021 to August 2022 were selected as the study objects, and were divided into reference group (n=100) and observation group (n=100) according to random number table method. The reference group received conventional western medicine treatment and electro-nape-acupuncture stimulation therapy, and the observation group was treated with Shenxian Jieyu Pills on the basis of the reference group. The total effective rate, language function, cognitive ability, daily living ability and the incidence of adverse reactions were compared between the two groups. **Result:** The total effective rate of the observation group was higher than that of the reference group, the difference was statistically significant (P<0.05). There was no significant difference in language function between the two groups before treatment (P>0.05); after treatment, the language function score of observation group was higher than that of reference group, the difference was statistically significant (P<0.05). Before treatment, there were no significant differences in the scores of activity of daily living scale (ADL) and Montreal cognitive assessment scale (MoCA) between the two groups (P>0.05);

* 基金项目：江西省中医药管理局科技计划项目（2021B165）

①江西省赣州市人民医院　江西　赣州　341000
通信作者：杨晓鸿

[18] 何聚，陈晓薇 . 肌肉能量技术结合心理干预对前交叉韧带重建术后膝关节功能的影响 [J]. 中国疗养医学，2022，31（10）：1088-1091.
[19] 孙姗姗，孟庆芳 . 肌肉能量技术治疗腰肌劳损的临床效果 [J]. 颈腰痛杂志，2022，43（2）：295-296.
[20] 崔显超，肖文武，高少君，等 . 肌肉能量技术联合关节松动术治疗创伤性肩周炎的疗效观察 [J]. 按摩与康复医学，2020，11（1）：37-38，42.
[21] 袁建，刘华 . 肌肉能量技术联合关节松动术和超短波疗法治疗肩周炎的临床疗效分析 [J]. 当代医学，2020，26（32）：152-153.

（收稿日期：2023-02-03）（本文编辑：郝天煜）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

after treatment, MoCA and ADL scores in the observation group were higher than those in the reference group, the differences were statistically significant ($P<0.05$). There was no significant difference in the incidence of adverse reactions between the two groups ($P>0.05$). **Conclusion:** Shenxian Jieyu Pills combined with electro-nape-acupuncture stimulation therapy has good effect in the treatment of dysphasia after stroke, which can effectively improve the language function and cognitive ability of patients, and the prognosis is good.

[Key words] Shenxian Jieyu Pills Electro-nape-acupuncture stimulation therapy Stroke Dysphasia Language function

First-author's address: Ganzhou People's Hospital, Jiangxi Province, Ganzhou 341000, China

doi：10.3969/j.issn.1674-4985.2023.29.029

中风是中老年人群的常见疾病，部分中风患者会发生不同程度的言语障碍。言语障碍是由大脑言语中枢的器质性病变引起的语言沟通能力障碍，包括自发谈话、听理解、复述、命名、阅读及书写能力残缺或丧失，不仅影响患者日常生活和工作质量，还会影响其身心健康[1-2]。临床针对中风后言语障碍常用西药治疗，但其恢复患者语言功能的效果较差。神仙解语丹出自清代程钟龄之的《医学心悟》，有行瘀通络，搜风化痰之功，对于中风后言语障碍患者有较好疗效[3]。另外有研究指出，电项针刺激疗法通过选穴和针刺手法配合电刺激，可直接作用于大脑皮层，恢复受损脑细胞，对于促进语言功能恢复有一定帮助[4]。但国内将二者联合用于中风后言语障碍治疗的研究较少。基于此，本研究特对 200 例中风后言语障碍患者展开调查，以此探析神仙解语丹联合电项针刺激疗法的作用价值，现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入赣州市人民医院 2021 年 10 月—2022 年 8 月接收的 200 例中风后言语障碍患者。（1）纳入标准：①经检查及临床症状综合分析，符合中风后言语障碍诊断[5]。②临床资料完整，精神状况良好，神志清晰。（2）排除标准：①肝肾功能不全；②参照病史和药品过敏史，对本研究中使用的药品过敏；③严重感染或恶性肿瘤。采用随机数字表法将患者分为参考组与观察组，各 100 例。告知本研究内容后，患者或家属同意并签订知情许可书。本研究经本院医学伦理委员会审核后批准同意执行，伦理编号：22546H。

1.2 方法

参考组采用常规西药和电项针刺激疗法治疗。（1）给予患者注射鼠神经生长因子 [生产厂家：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司，批准文号：国药准字 S20060023，规格：30 μg（15 000 U）/ 瓶] 30 μg，以 2 mL 注射用水溶解后肌注，1 次 /d；依达拉奉注射液（生产厂家：先声药业有限公司，批准文号：国药准字 H20031342，规格：5 mL∶10 mg）30 mg 混于 250 mL 氯化钠注射液（生产厂家：四川科伦药业股份有限公司，批准文号：国药准字 H51021158，规格：500 mL∶4.5 g）中静滴，2 次 /d。（2）电项针刺激疗法。①选取穴位为双侧翳风穴和风池穴；②针刺方向和深度：风池穴向鼻尖方向斜刺 0.8~1.2 寸，翳风穴直刺 0.8~1.2 寸（深度随患者体型变化）；③电流连接方法：同一组电极，正极连接一侧翳风穴，负极连接对侧风池穴，另一组与之相同；④电流波形与强度选择：连续波，频率为 4~8 Hz，电流强度以患者能耐受为度（针灸针能有轻微颤动最好）；⑤留针时间：30 min；⑥治疗周期：早晚针灸两次，周日当天针灸 1 次，两周为 1 个周期。观察组在参考组基础上采用神仙解语丹治疗。基本方为：远志 15 g，羌活 15 g，白附子 10 g，木香 10 g，天麻 15 g，全蝎 6 g，石菖蒲 15 g，胆南星 6 g，甘草 10 g。随症加减：痰热者加川贝母、全瓜蒌、竹茹清化热痰；兼肝阳上亢，头晕头痛，脸红，苔黄舌红者，加石决明、夏枯草、钩藤平肝潜阳；咽干舌燥者加天花粉；1 剂制丸 500 粒。20~30 粒 /d，分早晚服，生姜、薄荷煎汤送服，服药期间不宜吃生冷食物，刺激性食物。

两组治疗时间均为 1 个月。

1.3 观察指标及判定标准

（1）治疗效果参考文献 [6]《中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中（脑梗死）》，显效：治疗后患者语言功能恢复正常，失读失写消失，思维基本恢复；有效：患者语言功能显著好转，语言流畅度好转，发音清楚；无效：患者语言障碍无好转甚至加重，语言流畅度无改善。总有效 = 显效 + 有效。（2）言语功能采用《中国康复研究中心汉语标准失

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

语症检查量表》进行评分，项目包括听理解、复述、说、出声读、阅读、抄写、描写、听写和计算 9 项，根据每一项总分 / 总条目，各项目以 1~6 分评价，得分范围 9~54 分，得分越高则语言功能越好 [7]。（3）认知能力及日常生活能力：采用蒙特利尔认知评估量表（MoCA）及日常生活能力量表（ADL）评估。MoCA：该量表是一种快速评价患者认知功能损害的常用量表，其总分为 30 分，26 分及以上为正常，18~25 分为轻度认知障碍，10~17 分为中度认知障碍，10 分以下为严重认知缺陷 [8]。ADL：包括进食、穿衣、洗澡、排大小便等，总分为 100 分，分值越高日常生活独立能力越强 [9]。（4）记录两组不良反应，包括恶心呕吐、腹泻、消化不良。

1.4　统计学处理

数据纳入 SPSS 22.0 软件分析。符合正态分布的计量资料以（$\bar{x} \pm s$）表示，采用 t 检验；计量资料以率（%）表示，采用 χ^2 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组一般资料比较

参考组男 53 例、女 47 例；年龄 30~81 岁，平均（55.58 ± 4.13）岁；病程 2~11 周，平均（6.01 ± 1.29）周；类型：脑梗死 64 例，脑出血 36 例。观察组男 56 例、女 44 例；年龄 31~82 岁，平均（56.51 ± 4.21）岁；病程 2~12 周，平均（6.13 ± 1.21）周；类型：脑梗死 61 例，脑出血 39 例。两组一般资料比较，差异均无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。

2.2　两组治疗效果比较

观察组治疗总有效率明显高于参考组（$\chi^2=7.236$，$P=0.007$），见表 1。

表1　两组治疗效果比较[例（%）]

组别	显效	有效	无效	总有效
观察组（n=100）	71（71.00）	22（22.00）	7（7.00）	93（93.00）
参考组（n=100）	55（55.00）	25（25.00）	20（20.00）	80（80.00）

2.3　两组治疗前后语言功能比较

治疗前两组语言功能评分比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后观察组语言功能评分高于参考组（$P<0.05$）。见表 2。

表2　两组治疗前后语言功能比较[分，（$\bar{x} \pm s$）]

组别	治疗前	治疗后
观察组（n=100）	16.39 ± 3.42	38.25 ± 6.72
参考组（n=100）	16.49 ± 3.61	27.31 ± 5.59
t 值	0.201	12.515
P 值	0.841	0.000

2.4　两组治疗前后认知能力及日常生活能力比较

治疗前，两组 ADL、MoCA 评分比较，差异均无统计学意义（$P>0.05$）；治疗后，观察组 MoCA、ADL 评分均高于参考组（$P<0.05$）。见表 3。

2.5　两组不良反应发生率比较

两组不良反应发生率比较，差异无统计学意义（$\chi^2=0.421$，$P=0.516$），见表 4。

表3　两组患者治疗前后的认知能力及日常生活能力比较[分，（$\bar{x} \pm s$）]

组别	ADL		MoCA	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
观察组（n=100）	62.33 ± 2.51	84.01 ± 5.59	13.20 ± 3.89	25.65 ± 2.12
参考组（n=100）	62.17 ± 2.39	71.05 ± 5.62	13.47 ± 4.03	20.32 ± 3.08
t 值	0.462	16.349	0.340	16.396
P 值	0.645	<0.001	0.733	<0.001

表4　两组不良反应发生情况比较[例（%）]

组别	恶心呕吐	腹泻	消化不良	合计
观察组（n=100）	3（3.00）	2（2.00）	1（1.00）	6（6.00）
参考组（n=100）	2（2.00）	1（1.00）	1（1.00）	4（4.00）

3　讨论

从近年治疗脑卒中后言语障碍的文献来看，临床对其病因和发病机制的认识已经比较深入和统一 [10]。治疗方面，多运用神经心理学、影像学、电生理学等现代医学知识，以穴位针灸、穴位刺激及药物控制等方式联合进行干预治疗 [11-13]，但因方法不统一，以及受患者个体差异和其他因素影响，其治疗效果差异较大 [14-15]。此外，既往研究提示，穴位针刺在中医治疗中具有极其重要的地位，而针对言语障碍患者如何进行穴位配伍成为临床研究重点 [16-17]。电项针刺激疗法可以增加大脑皮层与语言功能相关区域组织的氧分压，并刺激该区域促进局部脑组织血液循环，加速受损脑细胞的修复，促进大脑皮层生物电活动的变化，从而帮助患者语言功能的恢复 [18]。

在本次研究中，观察组治疗总有效率明显高于参考组（$P<0.05$），提示神仙解语丹联合电项针刺激疗法治疗中风后言语障碍的效果更佳，肖忠源 [19] 研

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

究中也指出，神仙解语丹联合针刺治疗中风后言语障碍具有良好的治疗效果。分析其原因发现，神仙解语丹有熄风、化痰、开窍和活血化瘀之效，对心脾经受风、舌强不语和半身不遂有良好效果。现代医学对电项针刺激疗法治疗脑卒中后言语障碍的机制研究发现，治疗后患者的脑电图和脑血流图得到了显著改善，认为其作用机制包括：改善血液循环，增加脑血流量和恢复受损脑组织的血液供应；改善大脑的电活动，激活大脑的言语功能[20-21]。有研究证明，神仙解语丹和电项针刺激疗法均能改善中风患者脑电波，降低脑电地形图病理性高功率 θ 及 δ 波[22]。此外，本研究显示，观察组语言功能评分高于参考组，且观察组 MoCA、ADL 评分均高于参考组（$P<0.05$）。其原因可能是，中风后言语障碍是因脑卒中对语言中枢的损伤引起的，而神仙解语丹方中天麻可熄风止痉，祛风通络，石菖蒲化湿祛痰、开窍，共为君药；全蝎强祛风通络之力强，远志辅助石菖蒲开窍之功，胆南星可熄风定惊，白附子化痰，共为臣药；木香和羌活可祛湿除痰，共为佐药；甘草有调和阴阳之效为使药；诸药共奏祛痰开窍，活血化瘀之效。另外电项针刺激疗法可以通过机械刺激改善脑卒中后患者的脑功能，刺激病变周围可逆期的受损脑细胞的恢复[23]。除此之外，两组不良反应比较，差异无统计学意义（$P>0.05$），说明增加神仙解语丹治疗不会增加不良反应，其安全性较好。

综上所述，神仙解语丹联合电项针刺激疗法治疗中风后言语障碍的效果显著，可有效改善临床症状，提高患者语言能力，且不增加不良反应。

参 考 文 献

[1] 时连存，黄海燕 . 针刺治疗中风失语症的临床效果 [J]. 深圳中西医结合杂志，2021，31（10）：78-79.

[2] 吴颖 . 康复护理干预对脑中风失语患者的护理效果观察 [J]. 中国医药指南，2020，18（15）：257-258.

[3] 王妤函，郭琪，马乐，等 . 针灸治疗中风后失语的研究进展 [J]. 新疆中医药，2019，37（3）：130-133.

[4] 马晴，邵妍，王鹏琴 . 针刺和神经肌肉电刺激治疗中风后吞咽障碍研究进展 [J]. 实用中医内科杂志，2020，34（11）：14-17.

[5] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组，彭斌，等 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂志，2018，51（9）：666-682.

[6] 中医康复临床实践指南・缺血性脑卒中（脑梗死）制定工作组，章薇，娄必丹，等 . 中医康复临床实践指南・缺血性脑卒中（脑梗死）[J]. 康复学报，2021，31（6）：437-447.

[7] 张庆苏，纪树荣，李胜利，等 . 中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析 [J]. 中国康复理论与实践，2005，11（9）：703-705.

[8] 秦若梦，罗财妹，李梦春，等 .MoCA 量表单项得分对认知障碍转归的预测 [J]. 中风与神经疾病杂志，2020，37（6）：494-497.

[9] 王颖，韩为，郭铁，等 . 针刺治疗中风后偏瘫患者 NDS、ADL、FCA 量表观察 [C]// 第十五届针灸对机体功能的调节机制及针灸临床独特经验研讨会暨第十一届针灸经络学术研讨会会议论文集，上海，2010.

[10] 王立霞 . 针灸治疗中风失语的临床研究 [C]// 中国针灸学会痛症专业委员会成立大会、第一届京鲁针灸高峰论坛暨山东针灸学会第十一届学术年会论文集，济南，2019.

[11] 王承惠，庞青民 . 针灸联合语言训练治疗中风后语言障碍临床观察 [J]. 实用中医药杂志，2021，37（5）：870-871.

[12] 熊新林，秦芬，王利 . 基于《金匮要略》治未病理论探讨中风病的防治 [J]. 中国疗养医学，2022，31（6）：623-625.

[13] 陈浏阳 . 针刺五泉穴联合强制性诱导语言疗法对中风后运动性失语症患者功能性语言沟通能力评分的影响 [J]. 中医临床研究，2020，12（22）：41-43.

[14] GREENER J，ENDERBY P，WHURR R.Speech and language therapy for aphasia following stroke (Cochrane Review)[J]. Cochrane Database of Systematic Reviews (Online)，2000，4（2）：CD000425.

[15] 林宇，俞征宙，康佳，等 . 针刺上廉泉联合解语丹治疗中风后语言謇涩 18 例疗效观察 [J]. 国医论坛，2019，34（4）：31-32.

[16] 梅丽霞 . 通督调神针刺法辅助语言康复训练对中风后失语患者 CRRCAE 评分及血液流变学的影响 [J]. 中医药临床杂志，2020，32（8）：1498-1501.

[17] 付成保，李辉，陈波，等 . 解语丹加减联合针刺治疗中风后失语症的临床效果 [J]. 临床医学研究与实践，2019，4（30）：141-142.

[18] 尹春胜，张超，孟祥刚，等 . 针刺治疗中风的量效和时效研究现状 [J]. 上海针灸杂志，2022，41（8）：824-830.

[19] 肖忠源 . 神仙解语丹加减联合醒脑开窍针刺疗法治疗中风后失语的临床效果观察 [J]. 河南医学研究，2018，27（15）：2793-2794.

[20] 崔娜，于博，姜瑾 . 电针刺激神经干疗法治疗脑卒中言语障碍的疗效观察 [J]. 陕西中医，2016，37（7）：915-916.

[21] 刘大平 . 电项针结合头针疗法治疗中风后小脑性共济失调 60 例 [J]. 中国中医药科技，2011，18（3）：257-258.

[22] 姜晔，孙善斌 . 搓法针刺舌三针结合神仙解语丹治疗中风后失语的临床研究 [J]. 按摩与康复医学，2021，12（22）：51-53.

[23] 刘源源，祝婕 . 神仙解语丹加减联合舌三针治疗中风后失语症 51 例临床疗效观察 [J]. 世界中医药，2016，11（9）：1752-1754，1757.

（收稿日期：2023-02-15）（本文编辑：陈韵）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net